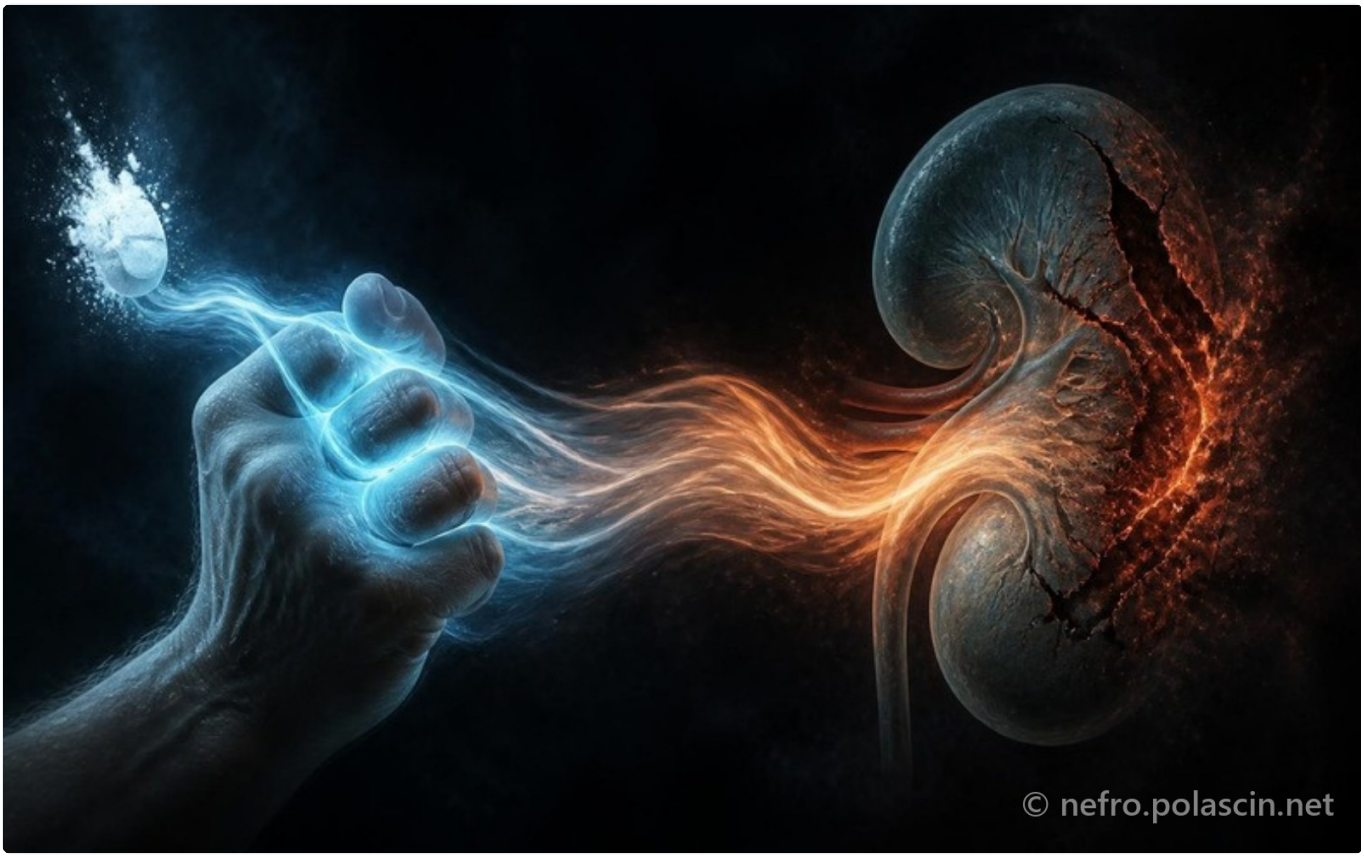
Chronická bolesť pri chronickej chorobe obličiek: ktoré analgetikum a za akú cenu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna, nie klinický záznam. Tá istá stuha svetla, ktorá uvoľňuje bolesť v ruke, dopadá na obličku ako žiar. Pri CKD nejde o to, či analgetikum účinkuje – ale o to, čo stojí na druhom konci.

Chronická bolesť je u pacientov s chronickou chorobou obličiek bežná, poddiagnostikovaná a poddliečená. Dôvod nie je ľahostajnosť: pri CKD je **problematické prakticky každé bežné analgetikum**, len každé iným spôsobom. Výsledkom býva buď zbytočné utrpenie, alebo liečba, ktorá sa po čase prejaví ako akútne poškodenie obličiek, hyperkaliémia, delírium či pád.

Tento článok neponúka univerzálny recept – neexistuje. Ponúka rámec na rozhodovanie a tri okruhy liekov, pri ktorých sa v nefrologickej ambulancii rozhoduje najčastejšie.

Rámec: neopioidná liečba má prednosť

Najcitovanejším rámcovým dokumentom sú **odporúčania CDC pre predpisovanie opioidov pri bolesti (2022)**, publikované v *MMWR Recommendations and Reports*. Aktualizujú dokument z roku 2016 a pokrývajú akútnu (trvanie pod 1 mesiac), subakútnu (1 až 3 mesiace) aj chronickú (nad 3 mesiace) bolesť u ambulantných pacientov od 18 rokov. **Nevzťahujú sa** na bolesť pri kosáčikovej anémii, na onkologickú bolesť ani na paliatívnu a terminálnu starostlivosť.

Dokument je postavený na metodike GRADE a rieši štyri okruhy: či vôbec začať opioid, výber opioidu a dávky, dĺžku úvodného predpisu a kontroly, a posúdenie rizika a riešenie potenciálnych škôd.

Dve vety z neho stojí za to prečítať doslova, pretože sa obe v praxi pravidelne skresľujú:

- **„Osoby s bolesťou majú dostať primeranú liečbu bolesti“** – s dôkladným zvážením prínosov a rizík *všetkých* možností liečby v kontexte situácie pacienta. Dokument nie je návodom na nepredpisovanie.

- **„Odporúčania sa nemajú uplatňovať ako nepružné štandardy starostlivosti naprieč populáciami pacientov.“** Dokument to uvádza výslovne – práve preto, že predchádzajúca verzia sa v praxi uplatňovala ako rigidný limit.

Pre nefrológa z toho vyplýva pracovný postup, nie zákaz: **maximalizovať nefarmakologické a neopioidné možnosti, a opioid zvažovať až vtedy, keď očakávaný prínos prevažuje nad možnou škodou – s hodnotením rizika a s kontrolami.**

Okruh 1: nesteroidné antiflogistiká

Otázka, či sa NSAID dajú pri CKD používať bezpečne, je natoľko sporná, že časopis *Kidney360* jej venoval formát **PRO / CON / COMMENTARY** – teda dve protichodné stanoviská a komentár. To samo o sebe hovorí viac než ktorákoľvek jednotlivá veta: **zhoda neexistuje.**

Argumenty proti sú známe a vážne:

- NSAID majú nežiaduce účinky naprieč orgánmi – **obličky, gastrointestinálny trakt, kardiovaskulárny systém**.
- Pri CKD je riziko akútneho poškodenia obličiek klinicky významne vyššie, pretože inhibícia prostaglandínov odoberá obličke práve ten mechanizmus, ktorým si pri zníženej perfúzii udržiava glomerulovú filtráciu.
- Pacienti s CKD **už užívajú lieky, ktoré riziko AKI zvyšujú** – diuretiká a blokátory systému renín-angiotenzín-aldosterón. Kombinácia všetkých troch skupín je klasickou cestou k akútnemu zlyhaniu obličiek.
- K tomu sa pridáva riziko **hyperkaliémie** a zhoršenia kontroly krvného tlaku.

Že nejde o teoretickú obavu, ilustrujú aj údaje z inej oblasti. V retrospektívnej kohorte pacientov po totálnej endoprotéze kolena (*Journal of Arthroplasty*, 2025) bolo pridanie ketorolaku do lokálnej infiltračnej analgézie **u pacientov s CKD** spojené s vyšším výskytom AKI – **12,7 % oproti 2,0 %** ($p = 0,041$, po párovaní podľa skóre náklonnosti; $n = 114$). U pacientov *bez* CKD rozdiel nebol (2,0 % oproti 1,9 %; $n = 870$). Jediná perioperačná dávka – a desaťnásobný rozdiel vo výskyte AKI, ale len v tej skupine, ktorá už mala zníženú rezervu.

Praktický postoj

Rozumný postoj nie je „zakázať“, ale „nikdy to nepovažovať za bezpečné“. Ak je NSAID naozaj nevyhnutné:

- **čo najkratšie a v najnižšej účinnej dávke**,
- s plánom kontroly kreatinínu, eGFR, kália a krvného tlaku,
- s výslovným poučením pacienta, **kedy NSAID vysadiť** – pri dehydratácii, vracaní, hnačke alebo horúčkovitom ochorení,
- a s vedomím, že kombinácia s diuretikom a blokádou RAAS je tá, ktorej sa treba vyhnúť predovšetkým.

Pri pokročilej CKD a u dialyzovaných pacientov treba zvážiť aj to, čo sa pri rozhodovaní často prehliada: u pacienta so zachovanou reziduálnou funkciou obličiek je jej strata samostatná škoda, ktorá sa už nevráti. Riziko a prínos sa preto nerátajú rovnako u pacienta s eGFR 50 a u pacienta na peritoneálnej dialýze s reziduálnou diurézou. Dlhodobým renálnym dopadom bežne užívaných liekov vrátane NSAID sa venuje samostatný článok o PPI, H2-antihistaminikách a NSAID a progresii CKD.

Okruh 2: duloxetín a neuropatická bolesť

Duloxetín (inhibítor spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu) je pri chronickej bolesti dolného chrbta aj pri diabetickej neuropatii rozumnou neopioidnou voľbou – **ale má jasné renálne obmedzenie**.

Podľa preskripčných informácií sa duloxetín **neodporúča pri terminálnom zlyhaní obličiek a pri závažnom renálnom poškodení (odhadovaný klírens kreatinínu pod 30 ml/min)**. Dôvod je farmakokinetický a presvedčivý: po jednorazovej dávke 60 mg boli u pacientov s terminálnym zlyhaním obličiek na chronickej intermitentnej hemodialýze hodnoty C_{max} a AUC približne **dvojnásobné** oproti osobám s normálnou funkciou obličiek. Expozícia hlavných cirkulujúcich metabolitov (4-hydroxyduloxetín-glukuronid a 5-hydroxy-6-metoxyduloxetín-sulfát), ktoré sa vylučujú prevažne močom, bola **približne 7- až 9-násobne vyššia** – a pri

opakovanom podávaní by sa ešte zvyšovala.

Naopak pri **miernom až stredne ťažkom renálnom poškodení (klírens kreatinínu 30 až 80 ml/min)** sa zdanlivý klírens duloxetínu významne nemení a úprava dávky nie je potrebná.

Prakticky: duloxetín je použiteľný pri CKD G3, ale **pri CKD G4 a G5 a u dialyzovaných pacientov nie je vhodnou voľbou**. Overte v aktuálnom SPC konkrétneho prípravku – formulácie sa medzi krajinami líšia.

Okruh 3: gabapentinoidy a opioidy – lieky, ktoré sa pri CKD kumulujú

Gabapentinoidy

Gabapentín a pregabalín sa vylučujú obličkami nezmenené, takže pri poklese eGFR rastie expozícia nepriamo úmerne eGFR. Dôsledkom je zvýšené riziko útlmu, zmätenosti, pádov a fraktúr – a pri kombinácii s opioidmi aj respiračnej depresie. Téme je venovaný samostatný článok o bezpečnosti gabapentínu pri CKD a hemodialýze; konkrétne dávkovacie schémy podľa klírensu kreatinínu rozoberá článok o polyneuropatii pri CKD.

Opioidy

Pri opioidoch nie je hlavným problémom samotná účinná látka, ale **renálne eliminované aktívne metabolity**. Preto nie sú opioidy pri CKD jedna skupina – sú to liečivá s veľmi odlišným správaním:

- **Morfín** má aktívne metabolity (morfín-6-glukuronid, morfín-3-glukuronid), ktoré sa vylučujú obličkami a pri CKD sa kumulujú. Prejavom nie je len hlbší útlm, ale aj myoklonus, hyperalgézia a delírium.
- **Kodeín** je prekurzorom morfínu a zdieľa ten istý problém, pričom ho ešte komplikuje nepredvídateľná aktivácia cez CYP2D6.
- **Petidín** (meperidín) má neurotoxický metabolit norpetidín, ktorý sa kumuluje a znižuje prah pre kŕče.

Spoločný záver je ten, ktorý už poznáme z gabapentinoidov: **začínať nízko, titrovať pomaly, sledovať útlm, zmätenosť a riziko pádu, a pri každej kontrole prehodnotiť, či liek ešte prináša úžitok.** Konkrétnu voľbu a dávkovanie viažte na aktuálne SPC a na klinický stav, nie na zvyk.

Osobitne treba zdôrazniť kombináciu **opioid plus gabapentinoid**. Ide o najčastejšiu dvojicu pri neuropatickej bolesti a zároveň o kombináciu, pred ktorou FDA výslovne varuje pre riziko závažnej respiračnej depresie – najmä u starších pacientov a pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.

Čo pri CKD často chýba: nefarmakologická liečba

Rámec CDC kladie nefarmakologickú liečbu na začiatok, nie na koniec po zlyhaní liekov. Pri CKD je to o to dôležitejšie, že výber liekov je obmedzený. Prakticky dostupné sú:

- **pohybová a cvičebná terapia** – pri chronickej bolesti chrbta má najlepší dôkazový základ zo všetkých nefarmakologických postupov a u pacientov s CKD prináša navyše prínos pre svalovú silu a funkčnú kapacitu,
- **psychologická intervencia** vrátane postupov zameraných na zvládanie bolesti,
- **lokálna liečba** – kapsaicín a lokálne anestetiká pri lokalizovanej neuropatickej bolesti; systémová expozícia je minimálna, čo je pri CKD podstatná výhoda,
- **manuálne a fyzikálne techniky** podľa dostupnosti.

Pri dialyzovaných pacientoch stojí za zváženie aj jednoduchá vec: významná časť bolesti súvisí s kŕčmi, s cievnym prístupom alebo s objemovým manažmentom – a tie sa neriešia analgetikom. Tému kŕčov rozoberá samostatný článok.

Praktický postup v ambulancii

1. **Určite typ bolesti.** Nociceptívna, neuropatická alebo zmiešaná – liečba sa volí podľa dominantného mechanizmu, nie podľa toho, čo „naposledy zabralo“.
2. **Zistite trvanie** a odlíšte akútnu od chronickej bolesti (nad 3 mesiace); liečebná stratégia sa líši zásadne.
3. **Spustite nefarmakologickú liečbu hneď**, nie až po zlyhaní liekov.

4. **Pred každým predpisom skontrolujte eGFR a celú medikáciu** – konkrétne diuretikum, blokádu RAAS, inhibítor SGLT2 a všetky lieky tlmiace centrálny nervový systém.
5. **Vyberte liek s ohľadom na renálnu funkciu:**
    - NSAID – len krátkodobo, ak vôbec, s monitorovaním a s pravidlom chorého dňa,
    - duloxetín – použiteľný pri miernom až stredne ťažkom poškodení, nie pri klírense pod 30 ml/min,
    - gabapentinoidy – nízka štartovacia dávka, pomalá titrácia, sledovanie útlmu a pádov,
    - opioidy – pozor na renálne eliminované aktívne metabolity; vyhýbať sa kumulácii.
6. **Prehodnoťte skoro a potom pravidelne.** Hodnoťte nielen intenzitu bolesti, ale aj **funkčný dopad** a znášanlivosť. Liek, ktorý znížil bolesť o dva body, ale pacient po ňom spí celý deň a dvakrát spadol, nie je úspech.

Čo tento prehľad nehovorí

- **„Nepredpísať nič“ nie je bezpečná voľba.** Neliečená chronická bolesť zhoršuje spánok, náladu, pohyblivosť aj adherenciu k ostatnej liečbe – a u krehkého pacienta vedie k nehybnosti, úbytku svaloviny a pádom.
- **Prahy pre NSAID pri CKD nie sú podložené randomizovanými dátami.** Pochádzajú z pozorovacích údajov a odborného konsenzu; práve preto o nich existuje otvorená odborná debata.
- **Odporúčania CDC sú americké** a vznikli v kontexte opioidnej krízy v Spojených štátoch. Ich logika – prednosť neopioidnej liečby, hodnotenie rizika, kontroly – je prenosná; konkrétne regulačné detaily nie.

Zdroje:

1. Dowell D, Ragan KR, Jones CM, Baldwin GT, Chou R. *CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain — United States, 2022.* MMWR Recomm Rep 2022;71(3):1–95. doi:10.15585/mmwr.rr7103a1 (PMID 36327391).
2. Guthrie B. *Can NSAIDs Be Used Safely for Analgesia in Patients with CKD?: CON.* Kidney360 2020;1(11):1189–1191. doi:10.34067/KID.0005112020 (PMID 35372868).
3. Baker ML, Perazella MA. *Can NSAIDs Be Used Safely for Analgesia in Patients with CKD?: COMMENTARY.* Kidney360 2020;1(11):1192–1194. doi:10.34067/KID.0004652020 (PMID 35372870).
4. Chee BRK, Quah ESH, Zhao CXS, Tan KGP, Thwin L. *The Addition of a Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug in Local Infiltration Analgesia During Total Knee Arthroplasty Increases the Risk of Acute Kidney Injury in Patients Who Have Renal Impairment.* J Arthroplasty 2025;40(4):916–922. doi:10.1016/j.arth.2024.10.020 (PMID 39447933).
5. Preskripčné informácie duloxetínu (CYMBALTA), sekcie *Use in Specific Populations — Renal Impairment* a *Clinical Pharmacology*. DailyMed.

Bibliografické údaje prác 1 až 4 boli overené v databáze PubMed.

Upozornenie: *Článok je určený zdravotníckym pracovníkom a nenahrádza platné súhrny charakteristických vlastností liečiv ani individuálne klinické rozhodnutie. Dávkovanie a renálne obmedzenia overte v aktuálnom SPC konkrétneho prípravku.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=chronicka-bolest-analgetika-bezpecnost-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.